

## 박○○ 어르신 — 1~7회차 관통 사례

회차마다 정보가 한 겹씩 드러납니다. 해당 회차 전에 그 부분만 읽으십시오.

## 읽기 전에

모든 인물·기관·수치는 가상입니다. 퇴원 요약과 처방 목록은 "실무자가 받아 적는 문서"의 예시일 뿐 의학 정보가 아닙니다. 약 이름은 계열만 적었습니다 — 해석하지 않고 옮겨 적는 연습을 위해서입니다.

## A-0 · 1회차 시작 시 아는 것

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 성명·성별·연령대    | 박○○, 여, 70대 후반 (78세)                                     |
| 주소           | ○○시 ○○구 △△동 ○○아파트 3층 (엘리베이터 없음)                          |
| 의뢰 경로        | 협약병원(○○병원) 퇴원지원팀 사회복지사 전화. 시군구 통보와 동시에 우리 기관(△△재가센터)에 의뢰 |
| 입원 사유        | 뇌경색으로 3주 입원. 퇴원 예정 5일 뒤(화요일)                             |
| 가족           | 남편 사별(5년 전). 딸 정○○(48세, 직장인, 차로 40분, 주 1회 토요일). 아들 없음    |
| 본인 말 (전해 들음) | "집에 가고 싶다. 딸한테 짐 되기 싫다."                                 |
| 장기요양         | 미신청                                                      |

## A-1 · 1회차 첫 통화에서 드러나는 것

- 오른쪽 팔다리 힘 약함. 보행기로 실내 보행 가능, 계단 불가. 삼킴·말 괜찮음. 혈압·당뇨 약 장기 복용
- 딸 연락처 받음. 퇴원 날은 휴가, 그 뒤 주말만
- 본인은 전화 가능. "와 주세요"
- 첫 방문: 토요일 10시 병실(딸 동석). 집 구조는 딸에게 사진 요청
- 퇴원 후: 2주 후 신경과 외래, 외래 재활 주 2회 권고

## A-2 · 2회차 첫 방문에서 드러나는 것 — 퇴원 요약 (가상·발췌)

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 진단      | 뇌경색(좌측). 후유증: 우측 상·하지 근력 저하(경도~중등도)                             |
| 기저 질환   | 고혈압(10년), 제2형 당뇨(8년)                                            |
| 현재 상태   | 의식 명료. 보행기 실내 보행 가능. 계단 보행 불가. 삼킴 양호(일반식). 언어 양호. 우측 손 세밀 동작 저하 |
| 퇴원 후 계획 | 신경과 외래 2주 후. 외래 재활 주 2회 권고(8주). 혈압·혈당 자가 측정 권고                  |
| 주의      | 낙상 주의. 재발 의심 증상(갑작스런 말 어눌·한쪽 힘 빠짐·심한 두통) 시 즉시 응급실               |

## 처방 목록 (가상 · 계열만)

| # | 계열    | 용법             | 비고                |
|---|-------|----------------|-------------------|
| 1 | 항혈소판제 | 1일 1회 아침       | 재발 예방 목적이라고 설명 들음 |
| 2 | 혈압약   | 1일 1회 아침       | 입원 전부터            |
| 3 | 당뇨약   | 1일 2회 아침·저녁 식후 | 입원 전부터            |
| 4 | 고지혈증약 | 1일 1회 저녁       | 입원 중 새로 추가        |
| 5 | 위장약   | 1일 1회 아침       | 1번과 함께            |

## 본인·딸·관찰에서 들은 것

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 몸 (ADL)   | 보행기로 병실 안 걷기(느림). 계단 불가. 앉고 서기(불잡고). 식사 왼손 가능. 화장실 혼자(시간 걸림). 목욕 도움 필요. 옷 입기 부분 도움(단추). 삼킴 괜찮음 |
| 생활 (IADL) | 식사 준비: 칼질·냄비 어려움. 장보기 불가. 약: "헛갈릴까 걱정", 봉지 못 뜯음. 돈 관리·전화 가능. 청소·빨래 어려움                         |
| 인지·정서     | 기억·판단 양호. 기분 가라앉음("내가 이렇게 될 줄"). 밤에 잠 못 잠                                                      |
| 가족·관계     | 딸 주 1회 토요일(남편·중2 자녀). 옆집 김○○씨(70대)와 반찬 나눔. △△교회 20년, 구역 식구, 교회 차량 봉사                           |
| 주거·환경     | 3층, 계단 36개. 현관 문턱 5cm. 화장실 문턱 10cm, 욕조, 손잡이 없음. 안방 요(침대 없음). 가스 레인지. 보일러 정상                    |
| 경제        | 기초연금 + 딸 월 30만원. 저축 약간. 수급·차상위 아님                                                              |
| 본인 의향     | "집에 가고 싶어요. 딸한테 짐 되기 싫고. 교회는 꼭 가고 싶어요. 밥은 내가 해 먹고 싶은데 손이..."                                   |
| 가족 의향 (딸) | "낮에 혼자 계신 게 제일 걱정. 주말엔 제가 가는데 평일이... 시설은 엄마가 절대 싫다고."                                          |
| 단골 약국     | 아파트 앞 ○○약국                                                                                     |

### A-3 · 3회차

새 정보 없음. 본인 우선순위: ① 교회 가기 ② 혼자 밥 해 먹기 ③ 약 안 헛갈리기. 실무자가 보는 위험: 계단·낙상, 약, 식사.

### A-4 · 4회차

새 정보 없음. 우리 지역에서 쓸 수 있는 서비스(S12 자원 지도)와 장기요양 등급 신청 절차(판정까지 약 30일)를 전제로 계획서 초안을 씁니다. 등급 판정 전 한 달 공백을 어떻게 메울지가 핵심.

### A-5 · 5회차 통합지원회의

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 참석 | 시군구 전담조직 주무관(주재), ○○병원 사회복지사, △△재가센터(우리), ○○방문간호센터, 보건소 방문건강관리. 본인·딸은 사후 설명 |
| 쟁점 | ① 등급 판정 전 30일 공백 ② 방문간호지시서 발급 경로(신경과 외래 2주 후) ③ 외래 재활 이동(계단) ④ 응급안전안심 대상 여부 |

### A-6 · 6회차

새 정보 없음. 순서가 있는 것들: 등급 신청 → 판정 → 방문요양·복지용구 / 외래 → 지시서 → 방문간호 / 응급안전안심 신청 / 주거개선 공고 / 교회 차량(본인이 직접) / 보건소 방문건강(회의 결과로 즉시).

### A-7 · 7회차 한 달 뒤 방문에서 드러나는 것

- 4등급 판정. 방문요양 주 3회(월·수·금 오전) 2주째. 요양보호사와 요리를 같이 함
- 방문간호: 지시서는 외래 때 발급, 센터 계약 늦어져 다음 주 시작
- 교회 1회(교회 차량 + 청년 2명 계단 부족). 외래 재활은 딸이 2회. 콜택시 예약 안 됨
- 요양보호사 안 오는 날(화·목) 끼니를 거름. "입맛이 없어." 먹는 양이 2주 전부터 줄었다고 본인·딸
- 밤에 못 자고 낮에 잠. 방문 때 피곤해 함
- 계단 혼자 시도하다 무서워서 포기. "그냥 집에 있을래"
- 약은 달력으로 잘 챙김. 봉지는 요양보호사가 미리 뜯어 둠
- 응급안전안심 설치 완료. 주거개선 공고 대기

김○○ 어르신 — 8회차 혼자 완주용

1~7회차 서식 7종으로 혼자 완주합니다. 모르는 것은 "확인 필요(누구에게)"에 적으십시오.

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 성명·성별·연령대 | 김○○, 남, 80대 초반 (83세)                                       |
| 주소        | ○○군 ○○면 단독주택. 마당 건너 화장실(15m 흠길), 마루 턱 20cm                 |
| 의뢰 경로     | 재활병원 퇴원 통보 → 시군구 → 우리 기관(기존 방문요양 이용 기관)                    |
| 입원 사유     | 집 마당에서 낙상 → 우측 고관절 골절 → 인공관절 수술 → 재활병원 4주 → 퇴원 예정 3일 뒤     |
| 가족        | 아내 이○○(80세, 무릎 관절염, 보행 느림). 아들(타 지역, 월 1회, 경제 지원). 딸 없음    |
| 장기요양      | 3등급(입원 전부터). 방문요양 주 2회 이용 중이었음                             |
| 본인 말      | "다시 넘어질까 무섭다. 화장실이 제일 걱정이다. 집에서 살다 죽고 싶다. 마을회관에 다시 가고 싶다." |
| 아내 말      | "내가 다 못 해요. 밤에 화장실 갈 때가 무서워요. 화장실만 어떻게 해 주면."              |

퇴원 요약 (가상·발췌)

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 진단·경과   | 우측 고관절 골절, 인공관절 치환술 후 4주. 체중 부하 허용                     |
| 현재 상태   | 보행기 보행 가능(실외 50m). 낙상 주의                               |
| 퇴원 후 계획 | 정형외과 외래 4주 후. 재활 운동 지속 권고(병원이 준 자가 운동지)                |
| 처방      | 골다공증약 주 1회(아침 공복, 30분 눕지 말라고 들음) / 진통제 필요시 / 혈압약 1일 1회 |

사정 요점

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 몸·생활  | 보행기로 실내 가능. 밤에 소변 2~3회. 식사·옷 입기 가능. 목욕 도움 필요. 아내가 식사 준비하나 무릎 때문에 장보기 어려움 |
| 인지·정서 | 양호. 넘어질까 불안 큼                                                            |
| 관계    | 동네 노인회장 출신, 친구 많음. 마을회관 200m. 기존 요양보호사와 신뢰                               |
| 환경    | 마당 화장실·마루 턱·흠길. 집 소유                                                     |
| 경제    | 아들 지원 + 기초연금                                                             |
| 강점    | 부부 사이 좋음. 마을 관계망. 회복 의지. 아들 지원                                           |
| 막는 것  | 환경(화장실·턱·흠길) / 마음(낙상 공포) / 몸(우측 다리) / 아내 체력                              |